

Т. Т Аманов, Г. Х.Жайтлеуов

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер ЗКО», г. Уральск

Внедрение радикальной цистэктомии в лечении инвазивного рака мочевого пузыря в хирургическое отделение онкодиспансера

Аннотация.

- Эпидемиология. Рак мочевого пузыря в первую очередь поражает мужчин. Соотношение мужчин и женщин, страдающих этим заболеванием, равняется 88:12. Причина возникновения рака неизвестна, но абсолютно доказанными являются профессиональные вредности. Сегодня известны около 40 профессий с высоким риском заболеваемости раком мочевого пузыря, большинство из которых относятся к резиновой и красильной промышленности. Ведущее значение в этиологии рака мочевого пузыря имеют курение и привычка длительно задерживать мочу в мочевом пузыре.
- Статистические данные в настоящее время свидетельствуют о росте онкоурологической заболеваемости во всем мире, в частности, рак мочевого пузыря в структуре онкозаболеваний США вышел на 5-е место.

В структуре онкологической заболеваемости населения Казахстана РМП занимает 15 ранговое место, составляя 4,0 на 100 тысяч населения (Арзыкулов Ж.А. с соавт. 2006). Из них 84% приходится на долю мужчин, 16% - на долю женщин.

- Эпидемиология рака мочевого пузыря в Западно-Казахстанской области за 2004-2013 гг.
- За период исследования по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 260 больных, что составляет в структуре злокачественных заболеваний 6,8%.

В Западно-Казахстанской области показатели заболеваемости по возрастным группам неоднородны (рисунок 1). Анализ заболеваемости данной локализации в области показал, что показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной группе среди лиц 00-29 и 30-39 лет только у мужского населения (0,1%000 и 0,5%000 соответственно).

Показатели варьировались с 0,9%000 до 3,4%000. Картина роста наблюдается. Среди лиц 50-59 лет у мужского населения (18,6%000), у женщин до 1,5%000. В данной возрастной группе заболеваемость рака мочевого пузыря в области зарегистрирована среди лиц 60-69 лет мужского населения 36,4%000, у женщин 2,8%000.

В возрастной группе 70 лет и старше. У мужчин (88,6%000), у женского населения (11,6%000).

Повозрастные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря мужского и женского населения в области за этот период в целом с увеличением возраста населения и имели бимодальный характер роста.

Ключевые слова:

Актуальность: Заболеваемость раком мочевого пузыря ежегодно возрастает, особенно в индустриально развитых странах, как в абсолютном числовом выражении, так и по отношению к частоте рака большинства других локализаций. Вместе с тем своевременная диагностика опухолей мочевого пузыря и лечение больных с данной патологией остаются сложными и актуальными проблемами современной онкологии, составляя 70% новообразований органов мочевого тракта и около 4% в структуре всей онкологической патологии. Среди всех онкоурологических заболеваний рак мочевого пузыря занимает 2 место после рака предстательной железы. Это связано со многими анатомо-физиологическими особенностями мочевого пузыря, склонностью опухоли к рецидивированию (частота возникновения рецидивов после органосохраняющих операций составляет 50-90%) и множественности поражения (нередко наблюдаются 2, 3 и более опухолей, тотальное опухолевое поражение).

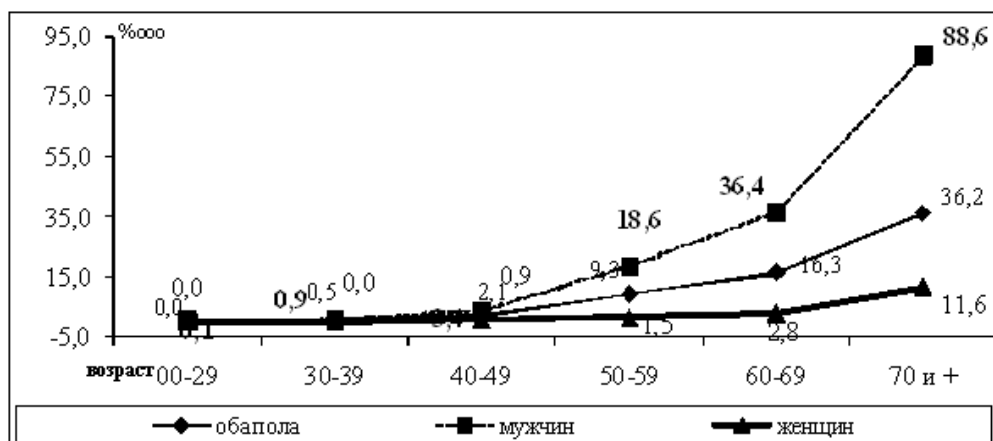


Рисунок 1 - Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря населения Западно-Казахстанской области за 2004-2013 гг.

Динамика заболеваемости (рисунок 2) рака мочевого пузыря в Западно-Казахстанской области характеризуется колебаниями с 4,6‰ (2004г.) до 3,7‰ (2007г.), затем в 2008 году отмечается рост до 5,7‰, и в конце исследования данный показатель составил 4,7‰ (2013г.). Темпы интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости данной локализации составили $T_{ин} = -0,06\%$ и $T_{ст} = -0,08\%$ соответственно.

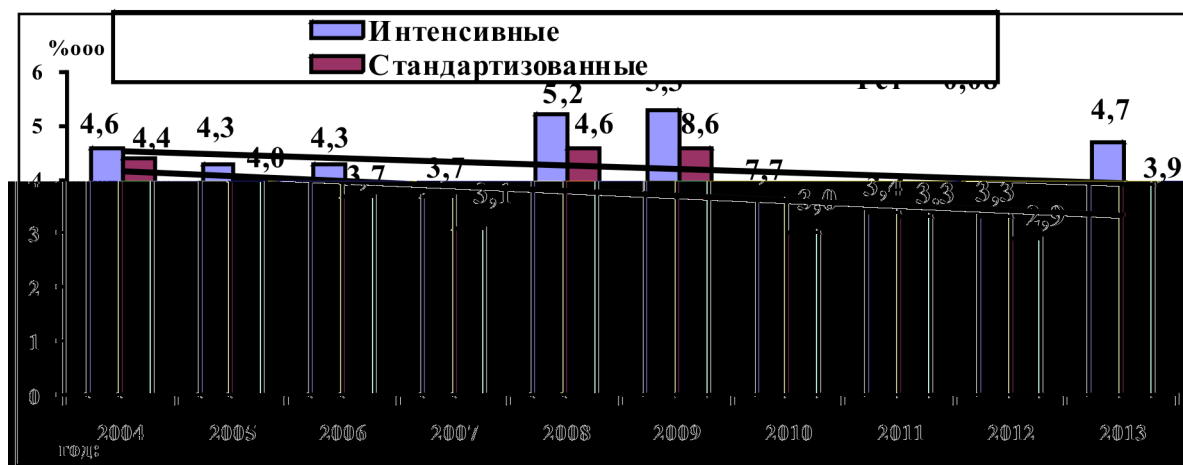


Рисунок 2– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря населения Западно-Казахстанской области за 2004-2013гг.

Среди мужского населения области показатели заболеваемости начиная с 8,2‰ (2004г.) имели тенденцию снижения до 6,1 ‰ (2007г.), затем последовал рост заболеваемости до 9,7‰ (2009г.), в конце исследуемого периода показатель составил 8,0‰ (рисунок 3).

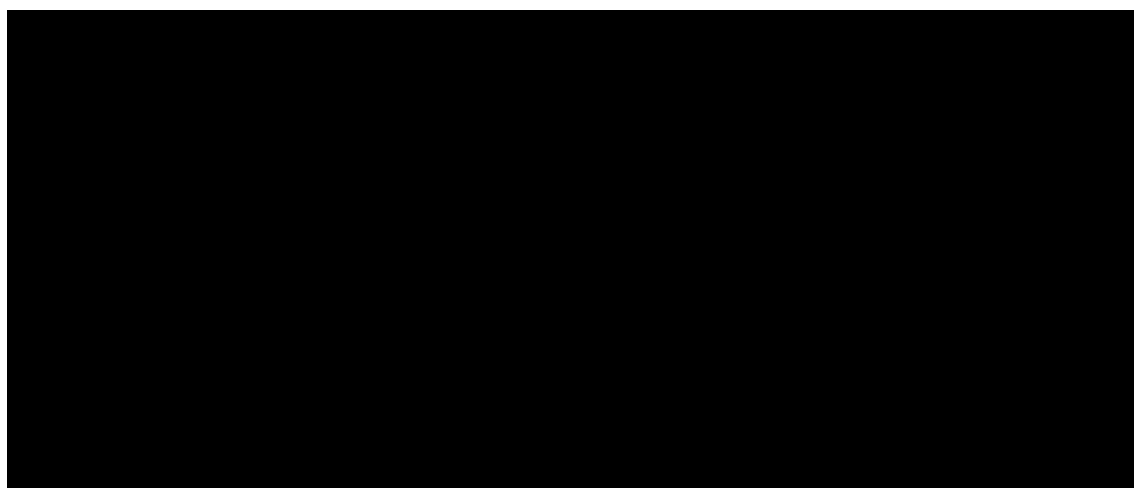


Рисунок 3– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря мужского населения Западно-Казахстанской области за 2004-2013гг.

Динамика заболеваемости данной локализации среди женского населения характеризуется колебаниями в виде показателя до 1,6‰ в середине изучаемого периода с последующим снижением до 0,6‰ (2012 г.) в последнем году исследования составил 1,6‰ (рисунок 4).

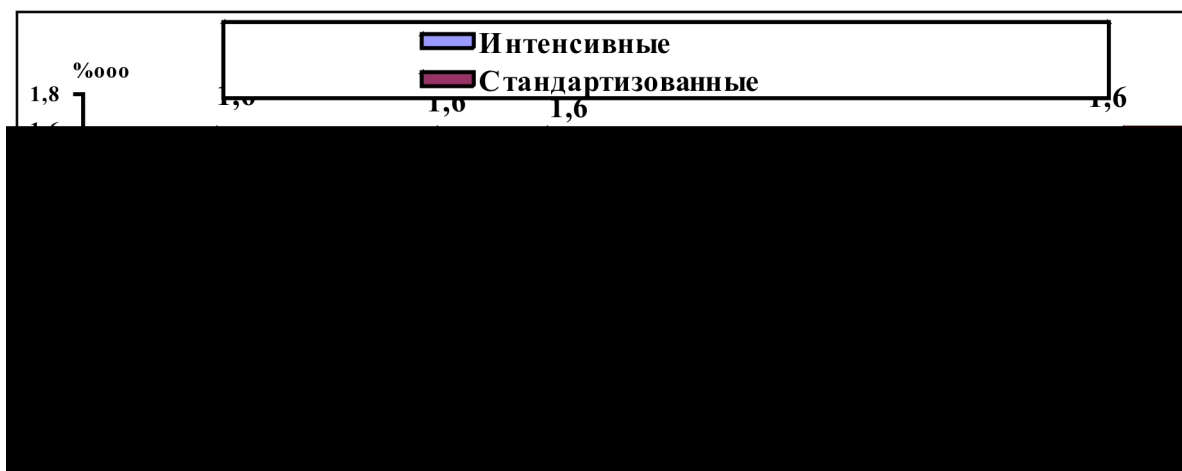


Рисунок 4– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака мочевого пузыря женского населения Западно-Казахстанской области за 2004-2013гг.

Удельный вес рака мочевого пузыря всего населения в Западно-Казахстанской области был высоким (Рис.5) в возрастных группах 60-69 лет (23,1%) и 70 лет и старше (45,8%) и имеет бимодальный характер роста. У мужчин удельный вес в данных возрастных группах составляет 25,13 %, и 42,5 % соответственно. У женщин высокие показатели наблюдались в возрасте 70 лет и старше 63,4%. Высокие показатели в указанной возрастной группе среди женщин обусловлены малым количеством зарегистрированных больных по данной локализации.

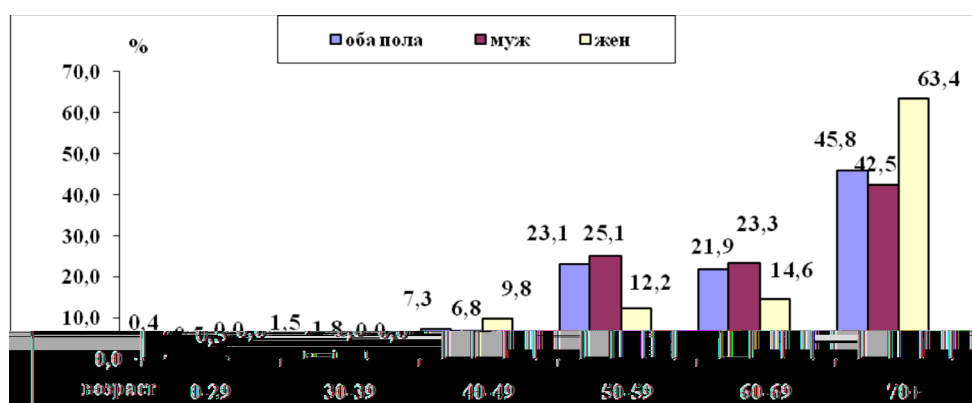


Рисунок 5 – Удельный вес рака мочевого пузыря по возрастным группам населения Западно-Казахстанской области за 2004-2013гг.

Таким образом, анализ динамики заболеваемости рака мочевого пузыря в Западно-Казахстанской области показал, что общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости составил $4,2 \pm 0,2$ ‰, стандартизованный (мировой) – $3,8 \pm 0,2$ ‰. Пик высокой заболеваемости отмечен среди лиц 70 лет и старше как у мужского, так и женского населения области.

Сложность диагностики рака мочевого пузыря на начальных стадиях объясняется бессимптомной картиной заболевания. У большинства пациентов причиной обращения к урологу служит гематурия, появляющаяся, чаще всего, на II-III стадиях заболевания.

Увеличение показателей заболеваемости раком мочевого пузыря по Западно-Казахстанской области, а так же увеличение доли пациентов с начальной стадией РМП - объясняется улучшением уровня амбулаторной диагностики на уровне ПМСП. На сегодняшний день,

практически все урологические кабинеты городских поликлиник и ряда районных больниц оснащены диагностическими уретероскопами, что значительно упрощает процесс диагностики рака мочевого пузыря на начальных стадиях.

В 2014 году на учет взято всего 32 человек. Из них на I - II стадии 18 чел. За 9 месяцев 2015 года на учет взято всего 122 человек. Из них на I – II стадии 26 чел.

С приобретением Видеоэндоскопического комплекса для урологии фирмы Карл Шторц, Германия, решена проблема диагностики, определения опухолевой инвазии стенки мочевого пузыря, а так же радикального оперативного лечения поверхностных и неинвазивных злокачественных поражений мочевого пузыря на 1 и 2 стадиях с последующей внутривезикулярной иммунотерапией.

Большую проблему онкоурологии представляет лечение инвазивной формы рака мочевого пузыря, ко-

торая наблюдается в 25% случаев (Б.П. Матвеев, 2003). Поверхностный рак мочевого пузыря, наблюдающийся в 70% случаев, в 50-90% случаев склонен к рецидивированию и в 10-15% случаев развивается инвазия в мышечный слой.

На сегодняшний день основным методом лечения инвазивного РМП является радикальная цистэктомия. По данным многочисленных исследований после радикальной цистэктомии общая 5-летняя выживаемость составляет 40-60%, что говорит об улучшении результатов лечения.

Под наблюдением в отделении хирургии ЗКО ООД с 2013 года находилось всего 28 больных с раком мочевого пузыря. Из них в начальной стадии – 18 больных, с инвазивным РМП – 10 больных, которым проведено оперативное вмешательство.

Из них в 8 случаях произведена резекция мочевого пузыря, в 12 случаях проведена ТУР мочевого пузыря и в 8 случаях произведена цистэктомия с илеопластикой по Бриккеру (ВСМП).

Из всего разнообразия существующих методов деривации мочи после радикальной цистэктомии, предпочтение отдано созданию илеопластики по Бриккеру.

Количество радикальных цистэктомий за последнее время возросло.

В отделении проведено всего 8 таких операций.

В 2013 году на базе нашего диспансера проведен мастер-класс

участием заведующего центра онкоурологии КазНИИОиР к.м.н. Нургалиева Н.С.- была проведена радикальная цистэктомия с илеопластикой по Бриккеру.

В 2014 году нами проведено 3 операции.

В 2015 году за 9 месяцев – 4 операции.

У всех больных гистологически был выявлен переходно-клеточный рак мочевого пузыря.

Важно отметить, что ранее за получением данного вида лечения больным приходилось выезжать за пределы области (КазНИИОиР г. Алматы, Самара, Оренбург и т.д.). Полученный опыт позволит уже в ближайшем будущем повысить доступность к перечисленным видам лечения и снизить смертность от онкологических заболеваний.

На данный момент изучается проведение перед цистэктомией неoadъювантной полихимиотерапии с целью повышение радикальности и ее влияние на отдаленные результаты лечения больных.

Также идет поиск наиболее оптимального метода создания резервуара с разработкой антирефлюксного механизма, различных пластических операций по созданию неoblадера из кишечника с восстановлением нормального акта мочеиспускания, что обеспечивает сравнительно лучшее качество жизни, чем при других методах.

Заключение. Анализируя статистические данные, результаты наблюдения за больными - можно сделать следующие выводы:

1. Снизились общие показатели летальности и запущенности РМП.
2. Улучшилось качество жизни больных с РМП, перенесших цистэктомию и операцию отведения мочи.
3. Проведение данных операций возможно у больных пожилого и старческого возраста.
4. Увеличилось качество и продолжительность жизни больных с РМП.

Тұжырым

Т.Т. Аманов, Г.Х. Жайтлеуов

ГКП на ПХВ «БҚО Облыстық онкологиялық диспансер»

Summary

T.T.Amanov, G.H.Zhantleuov

RSE on PVC "Regional Oncology Center of West Kazakhstan region"

Қуықтың инвазивті қатерлі ісігін емдеуіндегі радикалды цистэктомия

Қуықтың қатерлі ісігін емдеуінің негізгі әдістернің бірі – радикалды цистэктомия болып табылады. Бөлімшеде қуықтың қатерлі ісігі бар 28 науқас бақылауда болды. Олардың ішінде ерте сатыдағы – 18 науқасқа, және қуықтың инвазивті қатерлі ісігі бар – 10 науқасқа операциялық ем көрсетілді.

Солардың ішінен 8 науқасқа – қуықтың резекциясы жасалып, 12 науқасқа – қуықтың трансуретральды резекциясы жасалынды, сондай-ақ 8 науқасқа – цистэктомия Бриккер илеопластикасымен операциясы жасалынды. Бұл науқастарда өлім көрсеткіштерінің төмендеуі, және де өмір сапасының жақсаруы байқалынады. Бұл операцияларды егде жаста және қарт адамдарға да жасауға болады.

Түйінді сөздер: Қуықтың қатерлі ісігі, цистэктомия, илеопластика.

Radical cystectomy in the treatment of invasive bladder cancer

The main method of treatment of invasive bladder cancer is radical cystectomy. Under the supervision of the department there were 28 patients with bladder cancer. Of them, in the initial stage - 18 patients with invasive bladder cancer - 10 patients, performed surgery.

Of these 8 cases, resection of the bladder, in 12 cases - TUR of the bladder and in 8 cases performed cystectomy with ileoplastic's by Bricker. In these patients, decreased overall mortality rates, improved quality of life. Carrying out these operations possible in patients with middle and old age.

Key words: bladder cancer, cystectomy, ileoplastic.